

骨盆底肌治療計畫的統計分析與建模案件會議議程

會議主題：針對肛失禁患者的客觀資料進階分析與討論

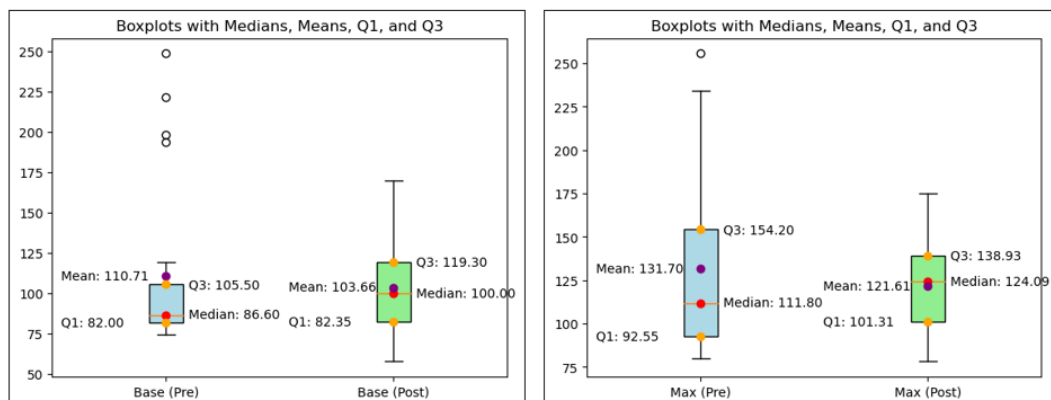
會議日期：8/01 週四，下午 17:00~19:00

會議內容：

我們把用在分析便秘症患者的手法一樣用在肛失禁患者身上：

▶ Data analysis –**肛失禁患者**

根據前面的檢定結果，我們知道最大值與基準值之間的 pre 跟 post 有顯著的差異，接下來我們想知道該差異到底是不是因為基準值不變但最大值變大，但從下圖我們可以很明顯地看出跟我們在便秘資料很類似的結果，就是在 Post 的肌電圖資料上都有明顯的趨勢向上，該 drift 的存在使得我們直接比較**基準值**跟**最大值**前後的差異其實是沒有意義的。



基本上我們可以看到在治療後期基準值與最大值卻值都有明顯地提升，因此我

們也沒辦法直接比較該基準值與最大值在接受治療前後的差異，這也更加一部

證實了我們的肌電圖資料確實會因為患者當天的身體狀況而有所差異，而我們

也直接針對患者在治療前後的基準值與最大值進行檢定：

Data analysis – 肛失禁患者

但我們還是可以將前後測的基值與最大值進行檢定來檢查是否真的是不顯著。對於基值，我們希望 post base 跟 pre base 沒有太大的差異，而最大值我們則是希望 post 的最大值可以大於 pre 的最大值。從以下的結果我們可以得到跟前一張盒鬚圖相似的結論，基準值跟最大值都沒有達到統計顯著

基準值檢定結果 – 雙尾檢定

	統計量	p-value
T test	0.786	0.445
Wilcoxon	45	0.669

最大值檢定結果 – 左尾檢定

	統計量	p-value
T test	0.469	0.676
Wilcoxon	53	0.524

得出該患者不論是在基準值或是最大值都沒有達到統計上的顯著水準，因此接

下來我們就可以依據我們分析便秘症患者的經驗，我們針對 resting tone 以

及其他的衡量指標來看肛失禁患者在接受過治療後是否更懂得用力，也就是說

resting tone 再接受過治療後是否有變的更大。

與會成員：

國立成功大學統計系 – 顏廷諭同學

國立成功大學醫學院附設醫院物理治療中心 – 黃挺鈞物理治療師